



DII: Complicações e Apresentações Clínicas

Apostila 2 · Páginas 21-40 · Gastroenterologia Clínica

DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL

Complicações da Retocolite Ulcerativa

A retocolite pode evoluir com quadros **graves e potencialmente fatais**.



Colite Grave Refratária



Sangramento Intenso



Megacólon Tóxico



Perfuração Intestinal



Câncer Colorretal

Colite Grave Refratária



Crterios Clnicos

- Mltiplas evacuaes com sangue
- Febre e Taquicardia
- Anemia + Inflamao sistmica

📋 ⚠ Sem resposta ao corticoide
IV → alerta mximo

Manejo da Colite Grave

Conduta exige **decisão rápida e multidisciplinar**.

Admissão Hospitalar

IV corticosteroides e
monitorização contínua.

Terapia Avançada ou Cirurgia

Escalonar biológicos ou
indicar cirurgia.



Avaliação Cirúrgica

Consulta precoce com
equipe cirúrgica.

A janela terapêutica é estreita — cada hora conta na prevenção de complicações maiores.

Falha Terapêutica na Retocolite

Quando não há resposta ao corticoide:

- Imunobiológicos (anti-TNF, vedolizumabe)
- Ciclosporina IV
- Colectomia cirúrgica



Tempo de resposta é crítico

A demora na tomada de decisão aumenta o risco de complicações graves e mortalidade.



Megacólon Tóxico

Dilatação grave do cólon com **toxicidade sistêmica**.

Critério Radiológico

Diâmetro do cólon transversal > 6 cm

Sinais Sistêmicos

Febre, taquicardia, leucocitose, hipotensão

Fatores Desencadeantes do Megacólon



Antidiarreicos

Reduzem motilidade e favorecem distensão colônica



Infecções

C. difficile e outros patógenos entéricos



Medicamentos

Opioides, anticolinérgicos e outros agentes

Tratamento do Megacólon Tóxico



❏ Sem melhora rápida → cirurgia urgente. Mortalidade aumenta com retardo.

Perfuração Intestinal

Alta Mortalidade

Peritonite fecal com risco imediato de vida

Evolução Rápida

Deterioração clínica em horas

Conduta

Cirurgia de emergência imediata



Complicações da Doença de Crohn

A Crohn tende a apresentar complicações **estruturais progressivas**.

Abscessos

Coleções de pus no abdome, pelve ou psoas



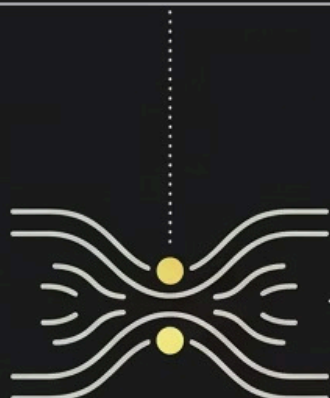
Fístulas

Conexões anômalas entre órgãos ou com a pele



Estenoses

Estreitamento intestinal causando obstrução

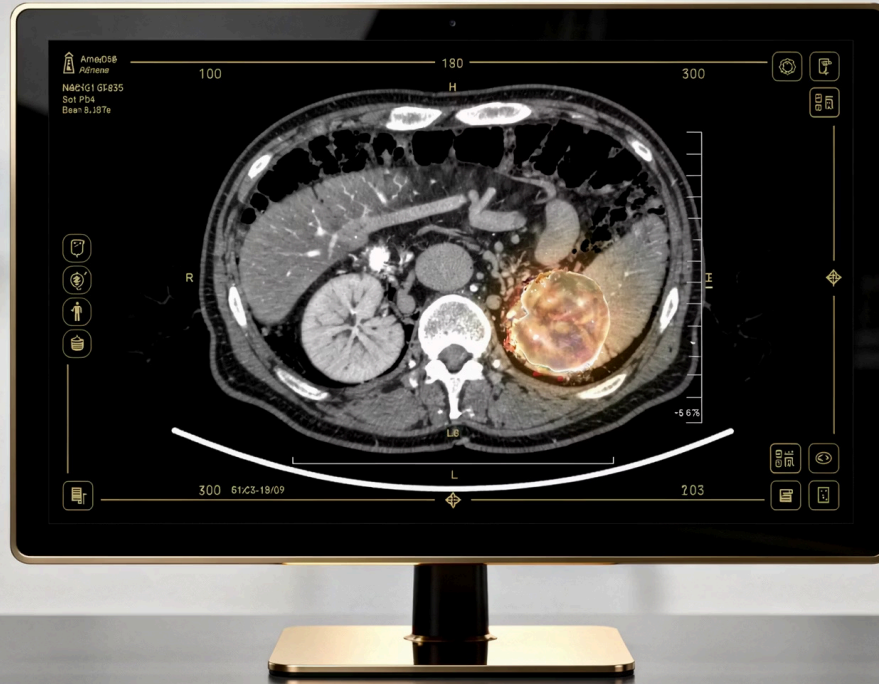


Obstrução Intestinal

Devido a inflamação crônica e fibrose



Abscessos na Doença de Crohn



Localizações frequentes:

Tratamento:

- Drenagem percutânea guiada por imagem
- Cirurgia nos casos complexos

Cavidade Abdominal

Região Pélvica

Músculo Psoas

Estenoses Intestinais

Resultado de **inflamação crônica** com fibrose progressiva da parede intestinal.

1

Inflamação Recorrente

Ativação persistente da mucosa

2

Fibrose da Parede

Remodelamento tecidual irreversível

3

Estreitamento do Lúmen

Única ou múltipla, assintomática a obstrutiva

Impacto e Tratamento das Estenoses

Manifestações Clínicas

Dor abdominal em
cólica

Distensão
abdominal

Obstrução intestinal

Opções Terapêuticas

01

Tratamento clínico

Controle da inflamação ativa

02

Dilatação endoscópica

Para estenoses curtas e acessíveis

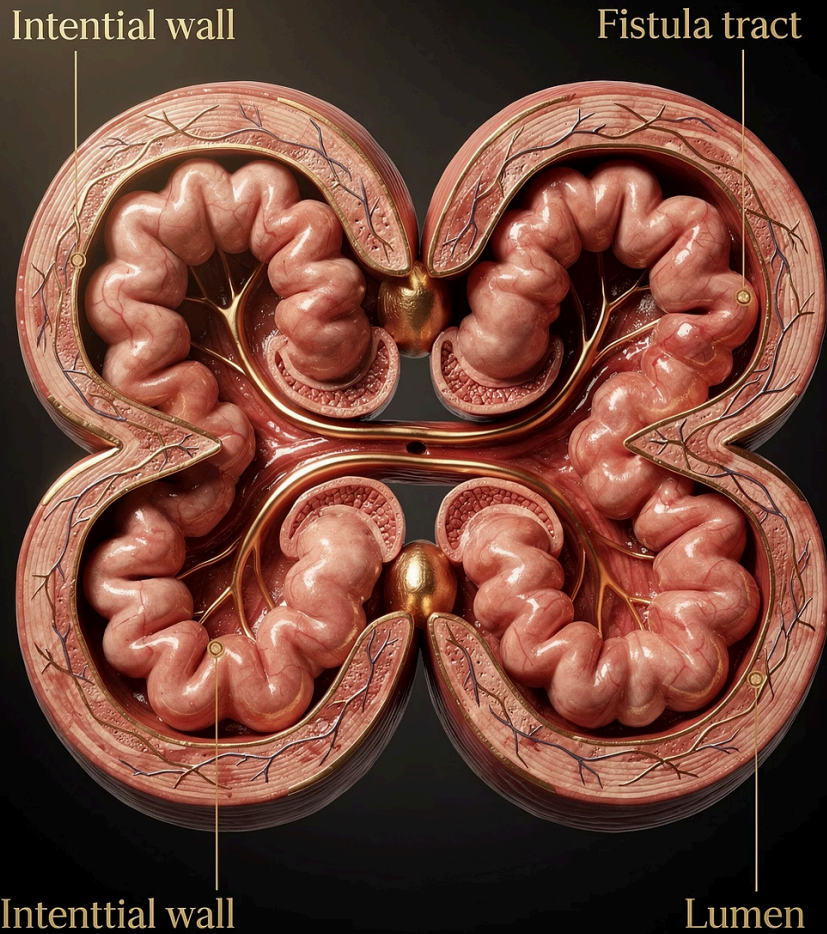
03

Cirurgia

Estenoplastia ou ressecção

Fístulas na Doença de Crohn

Conexões anormais entre estruturas — **alto impacto na qualidade de vida.**



Internas

Entre alças intestinais ou órgãos adjacentes



Externas

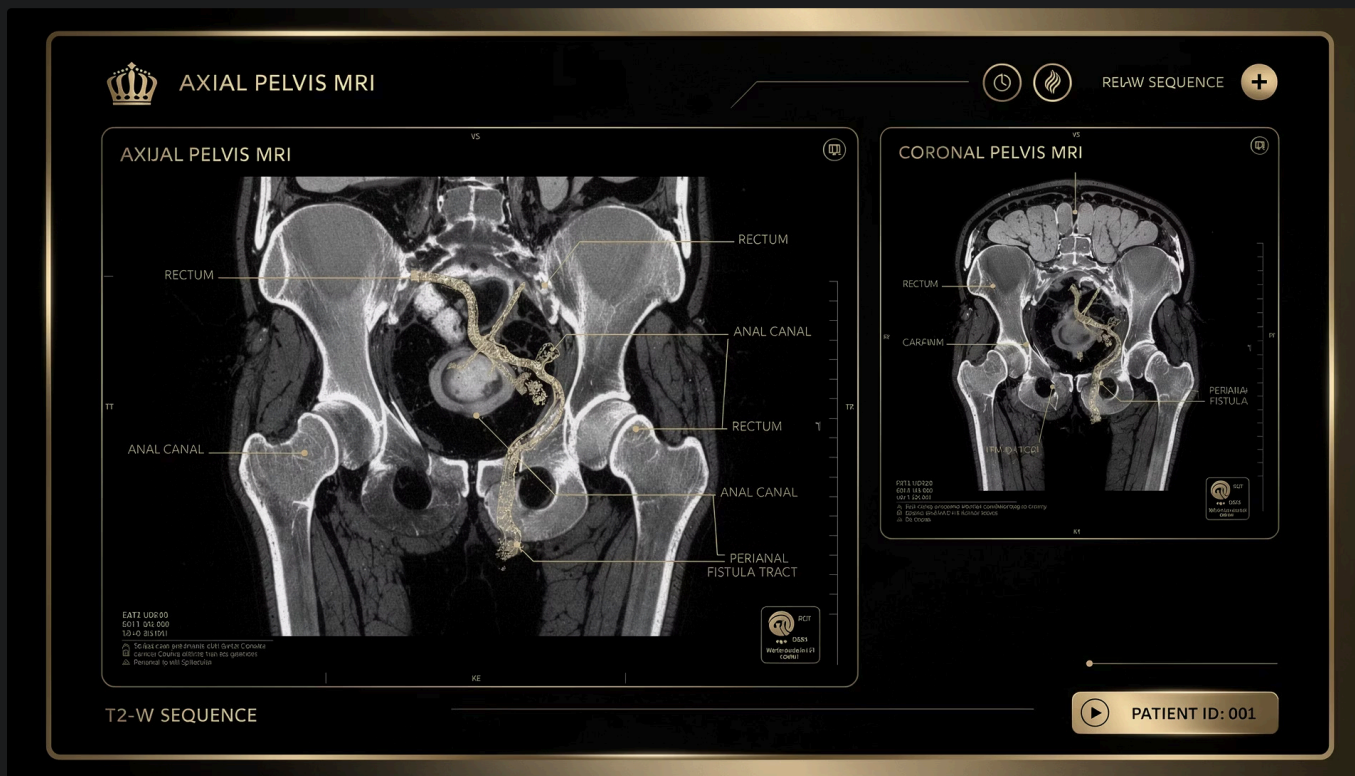
Comunicam intestino com a pele (enterocutâneas)



Anorretais

Forma mais comum na Crohn perianal

Avaliação das Fístulas



Avaliação Completa é Essencial

- RM pélvica
Mapeamento do trajeto fistuloso
- Ultrassonografia endoanal
Avaliação do esfíncter
- Avaliação clínica detalhada
Exame proctológico + histórico

Tratamento das Fístulas

Clínico

- Antibióticos (metronidazol, ciprofloxacino)
- Imunossupressores (azatioprina)
- Terapia biológica (anti-TNF)

Cirúrgico

- Drenagem de seton
- Fistulotomia / fistulectomia
- Correção do trajeto fistuloso

Fístulas Anorretais (Crohn Perianal)

Abordagem Combinada

01

Controlar a infecção ativa

Antibióticos + drenagem cirúrgica

02

Iniciar imunobiológico

Somente após controle infeccioso

03

Manutenção e vigilância

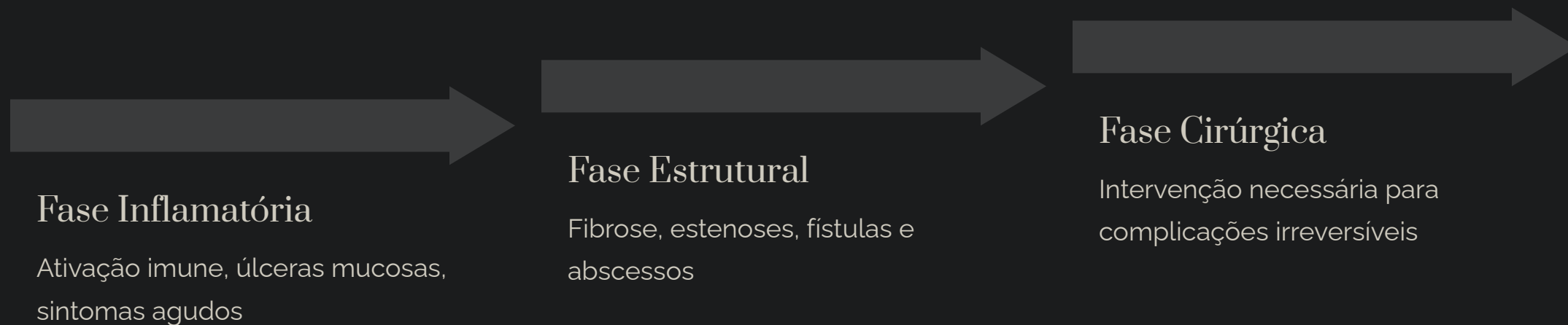
Seguimento clínico e por imagem



📌 ⚠️ Tratar infecção ANTES de
iniciar imunobiológicos

Progressão da DII

A DII é uma **doença dinâmica** com potencial de agravamento estrutural ao longo do tempo.



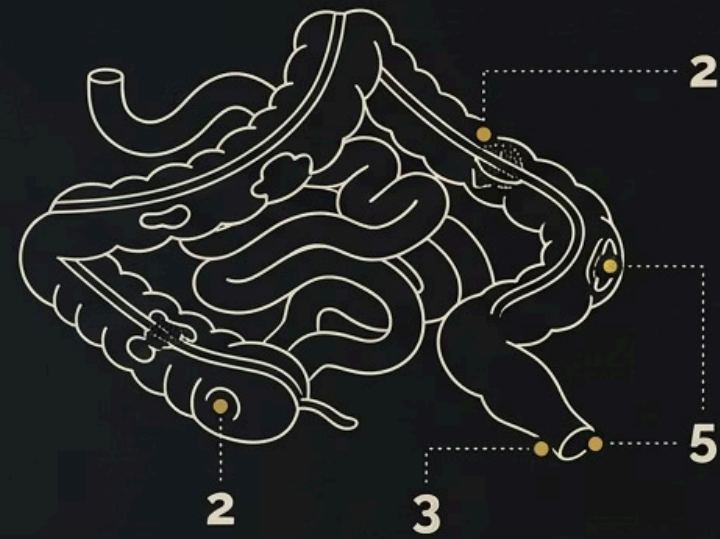
Visão Integrada das Complicações

Retocolite Ulcerativa



1. Colite Grave
2. Megacólon Tóxico
3. Perfuração
4. Sangramento
5. Câncer Colorretal

Doença de Crohn



1. Abscessos
2. Fístulas
3. Estenoses
4. Obstrução Intestinal
5. Crohn Perianal

Reconhecer o padrão de cada doença orienta a conduta clínica e a urgência da intervenção.



Pontos-Chave da Apostila 2

Reconheça a gravidade rapidamente

Colite grave, megacólon e perfuração exigem ação imediata

Crohn = complicações estruturais

Abscessos, fístulas e estenoses têm manejo específico e progressivo

DII é dinâmica

Inflamatória → Estrutural → Cirúrgica — intervenção precoce muda o prognóstico